

1. Introducción y relevancia clínica

El liquen plano (LP) es una **enfermedad inflamatoria crónica de la piel y las mucosas**, mediada por una respuesta inmunitaria contra los **queratinocitos basales**, que conduce a **lesiones pápulo-violáceas pruriginosas**.

Es una patología de curso **crónico-recidivante**, con importancia clínica por su **impacto estético**, su posible **asociación con infecciones virales (VHC)** y, en casos mucosos, por su **riesgo de transformación maligna**.

Epidemiología y relevancia

- Afecta al **0,5–2% de la población general**, más frecuente en adultos de 30–60 años.
 - No tiene predilección por sexo, aunque las formas mucosas son más comunes en mujeres.
 - En Chile, la mayoría de los casos son cutáneos, con afectación mucosa en 30–50%.
 - En EUNACOM, se pregunta frecuentemente por su **morfología característica y su diagnóstico diferencial con psoriasis, lupus y leucoplasias**.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El liquen plano es una **dermatosis inflamatoria autoinmune**, mediada por linfocitos T que reconocen antígenos alterados en los queratinocitos basales.

2.1. Mecanismo inmunológico

- Activación de **linfocitos T CD8+ citotóxicos** que destruyen queratinocitos basales.
- Liberación de **interferón gamma (IFN- γ)**, **IL-1**, **IL-6** y **TNF- α** , que perpetúan la inflamación.
- Resultado: degeneración vacuolar de la capa basal y cuerpos apoptóticos (*corpúsculos de Civatte*).

2.2. Factores desencadenantes y asociados

- **Fármacos:** antimaláricos, betabloqueadores, AINEs, metildopa, tiazidas, oro, penicilamina.
 - **Infección por virus de la hepatitis C (VHC)** — se recomienda su despistaje en todo paciente con LP.
 - Estrés emocional.
 - Traumatismos locales (*fenómeno de Koebner*).
 - Materiales dentales (amalgamas).
 - En raros casos, asociado a enfermedades autoinmunes o hepáticas.
-

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Lesión elemental

- **Pápula poligonal, plana, violácea, pruriginosa y brillante**, de 2–10 mm de diámetro.
- Superficie con **estrías blanquecinas finas en red** (*estrías de Wickham*).
- A menudo con **fenómeno de Koebner**: aparición de lesiones en zonas de trauma.

3.2. Formas clínicas principales

Forma	Características	Localización típica
Cutánea clásica	Pápulas violáceas, planas, con escamas finas, muy pruriginosas	Muñecas, antebrazos, tobillos, región lumbar
Mucosa oral	Placas blanquecinas reticulares o erosivas, con ardor o dolor	Mucosa bucal, lengua, encías

Ungueal	Estrías longitudinales, fragilidad, pterigio ungueal	Uñas de manos o pies
Genital (vulvar o peneana)	Placas blanquecinas o erosivas, dolor, dispareunia	Vulva, glande
Cuero cabelludo (liquen plano pilaris)	Alopecia cicatricial con eritema perifolicular	Cuero cabelludo
Actínico / anular / pigmentoso	Variantes menos frecuentes, predominan en fototipos altos	Cara, cuello o zonas expuestas

3.3. Síntomas principales

- **Prurito intenso**, a menudo el motivo de consulta.
 - Dolor o ardor en mucosa oral o genital.
 - En formas ungueales o pilosas: deformidad o pérdida permanente.
-

3.4. Diagnóstico diferencial

Patología	Diferencias clave
Psoriasis	Escamas plateadas, placas bien delimitadas, no violáceas
Lupus eritematoso cutáneo	Fotosensibilidad, atrofia central, ANA positivo
Liquen simple crónico	Lesión solitaria por rascado, sin estrías de Wickham

Candidiasis oral / leucoplasia	Placas blancas que no se desprenden, sin patrón reticular
Sífilis secundaria	Lesiones palmoplantares, serología positiva
Liquen escleroatrófico	Placas blanquecinas atróficas, sin color violáceo ni estrías

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Diagnóstico clínico

El diagnóstico es **principalmente clínico**, basado en las características morfológicas:

- Pápulas planas, violáceas, poligonales, con estrías de Wickham.
- Distribución simétrica, bilateral, en muñecas, tobillos o mucosa oral.

4.2. Exámenes complementarios

Examen	Indicación	Hallazgos
Biopsia cutánea	Casos dudosos o formas atípicas	Hiperqueratosis, degeneración vacuolar de capa basal, infiltrado en banda de linfocitos, cuerpos de Civatte
Serología para VHC (ELISA / PCR)	Recomendado en todo LP mucoso o diseminado	Puede ser positiva
Inmunofluorescencia directa	En lesiones mucosas erosivas	Depósito de IgM o fibrinógeno en la membrana basal

Exámenes hepáticos	Si hay sospecha de hepatitis o alteraciones asociadas	Elevación de transaminasas
---------------------------	---	----------------------------

4.3. Criterios diagnósticos

1. Pápulas planas violáceas, poligonales y pruriginosas.
 2. Estrías de Wickham visibles.
 3. Lesiones simétricas, distribución flexora.
 4. Infiltrado linfocítico en banda en histología.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El manejo se orienta a **controlar síntomas, reducir inflamación y prevenir secuelas cicatriciales**, especialmente en mucosas y uñas.

5.1. Tratamiento general

- Educar al paciente: curso crónico, recidivante.
 - Evitar rascado, irritantes y medicamentos sospechosos.
 - Tratar factores asociados (VHC, estrés).
-

5.2. Tratamiento tópico (primera línea)

Tipo de lesión	Tratamiento	Observaciones
Cutáneo leve o localizado	Corticoides tópicos potentes (clobetasol, betametasona) 1–2 veces/día	4–6 semanas, luego reducción progresiva

Mucosa oral o genital	Corticoides tópicos de alta potencia (clobetasol gel, fluocinonida) o enjuagues con triamcinolona 0,1%	Aplicar tras higiene oral
Cuero cabelludo (liquen pilaris)	Corticoides tópicos o intralesionales (triamcinolona 5–10 mg/ml)	Bajo control dermatológico
Uñas	Infiltración intralesional o corticoides tópicos oclusivos	Requiere seguimiento

Adjuntos tópicos:

- Antihistamínicos orales (loratadina, cetirizina) para el prurito.
- Emolientes para mejorar barrera cutánea.

5.3. Tratamiento sistémico (moderado-severo o refractario)

Fármaco	Dosis / indicación	Precauciones
Prednisona	0,5 mg/kg/día (10–30 mg) × 4–6 semanas, con descenso gradual	Evitar suspensión brusca
Metotrexato	7,5–25 mg/semana + ácido fólico	Control hepático y hematológico
Azatioprina	1–2 mg/kg/día	Alternativa en LP mucoso o erosivo
Ciclosporina A	2,5–5 mg/kg/día (corto plazo)	Nefrotoxicidad, HTA

Retinoides (acitretina)	0,3 mg/kg/día	Teratogénico
Fototerapia (UVB / PUVA)	En casos extensos o refractarios	Evitar en mucosas

Nota: En mucosa oral erosiva severa, se prefiere **ciclosporina o tacrolimus tópico**.

El **tacrolimus 0,1% pomada** es especialmente útil en lesiones genitales o faciales.

5.4. Tratamiento del liquen plano pilaris (cuero cabelludo)

- Corticoides tópicos potentes o intralesionales.
- Minoxidil 5% para estimular crecimiento.
- Si persiste: metotrexato o hidroxicloroquina.

5.5. Tratamiento del liquen plano oral

- Corticoides tópicos potentes o enjuagues con triamcinolona.
- En erosiones dolorosas: anestésicos tópicos (lidocaína viscosa).
- Antisépticos orales (clorhexidina 0,12%).
- Derivar a odontología y descartar displasia o carcinoma.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción	Manejo
--------------	-------------	--------

Pigmentación postinflamatoria	Común tras resolución de lesiones	Despigmentantes tópicos
Liquen plano erosivo mucoso crónico	Riesgo de carcinoma epidermoide (1–3%)	Vigilancia semestral
Alopecia cicatricial	En liquen pilaris	Diagnóstico precoz y tratamiento agresivo
Onicodistrofia irreversible	En formas ungueales	Infiltración temprana puede prevenir
Recidivas	En 20–40% de los casos	Mantenición tópica o sistémica

Pronóstico:

- En formas cutáneas: remisión espontánea en 1–2 años en 70%.
- Mucosas o pilosas: curso crónico, requieren seguimiento prolongado.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. Las **pápulas violáceas poligonales con estrías de Wickham** son patognomónicas.
2. El **fenómeno de Koebner** (lesiones en sitios de trauma) es frecuente.
3. Siempre **descartar infección por VHC** mediante serología.
4. En mucosa oral erosiva, **riesgo de carcinoma epidermoide** → vigilancia periódica.

5. **Corticoides tópicos potentes** son primera línea; sistémicos o inmunomoduladores si severo.
 6. En cuero cabelludo, el **liquen pilaris** produce **alopecia cicatricial irreversible**.
 7. En EUNACOM, la descripción típica es: “pápulas violáceas planas con prurito intenso y estrías blanquecinas en muñecas”.
-



Errores comunes

- Confundir con psoriasis (color y localización distintas).
 - No examinar mucosas o uñas (pueden dar el diagnóstico).
 - No solicitar serología para VHC.
 - Usar corticoides tópicos potentes prolongadamente sin control → atrofia.
 - Ignorar riesgo de malignización en lesiones mucosas crónicas.
 - Diagnosticar como “liquen simple crónico” sin corroborar morfología poligonal y color violáceo.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **liquen plano** es una enfermedad inflamatoria autoinmune, con **pápulas violáceas, planas, poligonales y pruriginosas**.
2. Puede afectar **piel, mucosas, uñas o cuero cabelludo**.
3. Las **estrías de Wickham** son características.
4. El diagnóstico es **clínico**, confirmado por **biopsia** si es necesario.
5. El **tratamiento de primera línea** son **corticoides tópicos potentes**; en casos extensos, inmunosupresores sistémicos.

6. Debe **descartarse infección por VHC** y controlar riesgo de carcinoma en mucosa oral.
7. En EUNACOM, la clave diagnóstica es: **lesiones violáceas, poligonales y pruriginosas con estrías blancas en muñecas o mucosa oral.**